

Comprendre mon taux de bêta-hCG

Cette fiche vous aide à comprendre les grandes lignes d'un dosage de bêta-hCG. Elle ne remplace jamais l'interprétation de votre médecin ou de votre sage-femme, seuls compétents pour analyser votre résultat dans votre contexte clinique.

LES SEUILS DE RÉFÉRENCE

< 5 UI/l

Négatif

> 5 UI/l

Positif

5 à 25 UI/l

Zone grise — recontrôle à 48 h

Le taux de bêta-hCG double généralement toutes les 48 à 72 heures en tout début de grossesse et atteint un pic entre 8 et 11 SA avant de redescendre en plateau.

TABLEAU INDICATIF DU TAUX D'hCG PAR SA

(Guide des analyses spécialisées Cerba — tableau 2, valeurs en UI/l)

VALEURS INDICATIVES — elles varient fortement selon les laboratoires et les femmes — ne remplacent pas l'avis médical.

SA	Taux (UI/l)	SA	Taux (UI/l)
4-5 SA	200 à 8 000	17-19 SA	8 000 à 70 000
5-6 SA	4 000 à 90 000	19-21 SA	8 000 à 44 000
6-7 SA	8 000 à 170 000	21-23 SA	8 000 à 36 000
7-8 SA	12 000 à 230 000	23-25 SA	8 000 à 34 000
8-9 SA	16 000 à 256 000	25-27 SA	6 000 à 38 000
9-10 SA	44 000 à 260 000	27-29 SA	10 000 à 46 000
10-11 SA	34 000 à 240 000	29-31 SA	16 000 à 48 000
11-12 SA	30 000 à 220 000	31-33 SA	22 000 à 44 000
12-13 SA	24 000 à 168 000	33-35 SA	18 000 à 42 000
13-15 SA	16 000 à 144 000	35-40 SA	12 000 à 34 000
15-17 SA	8 000 à 120 000		

SA = semaines d'aménorrhée, comptées depuis le premier jour des dernières règles.

Ce que le taux ne dit PAS

X Il ne date pas précisément la grossesse

La fourchette de valeurs possibles pour une même semaine est immense (parfois de 1 à 10). Seule l'échographie de datation (11 à 13 SA + 6 j) permet de dater précisément une grossesse.

X Il n'indique pas, à lui seul, une grossesse gémellaire

Un taux élevé peut l'évoquer, mais seule l'échographie confirme le nombre d'embryons.

X Il ne prédit pas, à lui seul, une fausse couche

C'est l'évolution du taux sur plusieurs dosages — et non une valeur isolée — qui oriente le diagnostic, en complément de l'échographie.

X Un taux isolé n'a pas de sens sans comparaison

C'est la progression entre deux prélèvements, en général espacés de 48 heures, qui est cliniquement informative.

■ SIGNAUX D'ALERTE

CONSULTER EN URGENCE si vous ressentez des douleurs pelviennes (surtout unilatérales) associées à un saignement, avec ou sans malaise ou fièvre : ces signes peuvent évoquer une grossesse extra-utérine ou une fausse couche.

AVERTISSEMENT MÉDICAL

Cette fiche est un outil d'information générale, publié par la rédaction de Health Corner à partir de sources médicales de référence (Cerba, Ameli). Elle ne fournit aucune interprétation individualisée de votre résultat et ne remplace jamais l'avis de votre médecin ou de votre sage-femme, seuls compétents pour analyser un dosage dans son contexte clinique. En cas de doute sur votre grossesse, consultez un professionnel de santé.

SOURCES

Laboratoire Cerba — Guide des analyses spécialisées, fiche hCG (documents.lab-cerba.com/files/FR/0268F.pdf)

Ameli — Suivi de la grossesse (ameli.fr)

Ameli — Grossesse extra-utérine, Fausse couche (ameli.fr)